HÔPITAUX Paris

Saint Joseph — Marie Lannelongue

LIVRET D'ACCUEIL

TOME 9

SITUATION SANITAIRE EXCEPTIONNELLE

SERVICE DES URGENCES

SOMMAIRE

1. Principe du damage control ..... - 3 -
2. AMAVI ..... - 5 -
Fiche réflexe « IDE plan amavi » ..... - 7 -
Fiche réflexe « IOA » ..... - 8 -
Fiche réflexe « missions des IDE des différentes zones : IMP / UR / UA » ..... - 9 -
Fiche réflexe « missions de l'IDE de la zone transitoire » ..... - 10 -
Fiche réflexe « IDE des lits d'urgences » ..... - 11 -
3. NRBC-E ..... - 12 -
Fiche réflexe « l'IDE NRBC » : ..... - 26 -
Fiche réflexe « l'IDE Trieur NRBC » : ..... - 27 -
Fiche réflexe : Mission de l'IDE douche (A créer) ..... - 28 -
4. CYBERATTAQUE ..... - 29 -
Procédure dégradée : laboratoire, imagerie, brancardage, ECG et pharmacie : ..... - 33 -
6. Procédure dégradée- Dossier papier ..... - 37 -
IOA ..... - 37 -
Observation médicale ..... - 38 -
Diagramme de soins ..... - 39 -
Autorisation ..... - 40 -
IOIO ..... - 40 -

1. PRINCIPE DU DAMAGE CONTROL

Avant d'aborder ce sujet, il est important d'en comprendre les fondamentaux.

Pour rappel :

L'État dispose de nombreux plans, développés au niveau local ou national en prévision d'accidents de grande ampleur et de catastrophes, destiné à favorisé la qualité de sa réaction et de ses actions.

Les plans s'appliquent à tous les échelons des différents ministères et service de l'État. Ils permettent de coordonner les actions entre les ministères et entre le niveau national et l'échelon territorial.

Les plans consistent notamment à :

- Permettre une optimisation de la mobilisation des ressources utiles pour faire face aux situations
- Faciliter et guider le processus de prise de décision des autorités publiques
- Proposer des mesures et plans d'action

Dispositifs nationaux :

- **ORSEC** : Organisation de la Réponse de Sécurité Civile.
- **ORSAN** : Organisation de la Réponse du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles (ce dispositif comprend 5 plans opérationnels de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles : AMAVI ; MEDICO-PSY ; EPI-CLIM ; REB ; NRC).

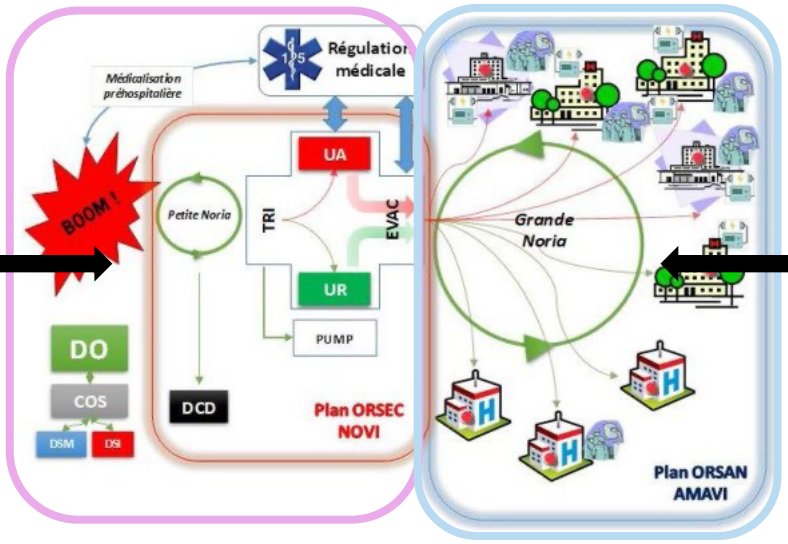
Plan d'urgence national :

- ➔ **NOVI** : Nombreuses victimes (plan d'urgence pour secourir un nombre important de victimes dans un même lieu) → Extra-hospitalier.
- ➔ **AMAVI** : Accueil massif de victimes non contaminées → Intra-hospitalier.

Dispositif de crise obligatoire dans chaque établissement de santé.

- ➔ **Plan blanc** = organisation qui permet de mobiliser immédiatement les moyens de toute nature dont il dispose en cas d'afflux de patients ou de victimes ou pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle.

PLAN ORSEC = NOVI



PLAN ORSAN = AMAVI = PLAN BLANC

Les 5 plans opérationnels de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles (ORSAN) :

AMAVI	EPI-CLIM	REB	NRC	MEDICO-PSY
Accueil massif de victimes non contaminées d'un événement grave	PEC des tensions dans l'offre de soins liées au nombre important de patients suite à une pandémie saisonnière et/ou lors d'un phénomène climatique, voire environnemental important	PEC des patients dans le cadre du risque épidémique et biologique connu ou émergent	PEC des patients dans le cadre d'un risque nucléaire, radiologique ou chimique	PEC médico-psychologique des patients victimes d'un événement grave
Catastrophe naturelle Accident technologique Attentats avec armes de guerre et/ou engins explosifs	*Canicules Grand froid*	*COVID EBOLA H5N1*	*Usine ASF (Toulouse) Tchernobyl / Fukushima*	*Accident, Catastrophe, Attentat*

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le site sante.gouv.fr :

https://sante.gouv.fr/prevention-en-sante/securite-sanitaire/article/le-dispositif-orsan-cadre-integre-de-preparation-et-de-reponse-du-systeme-de

2. AMAVI

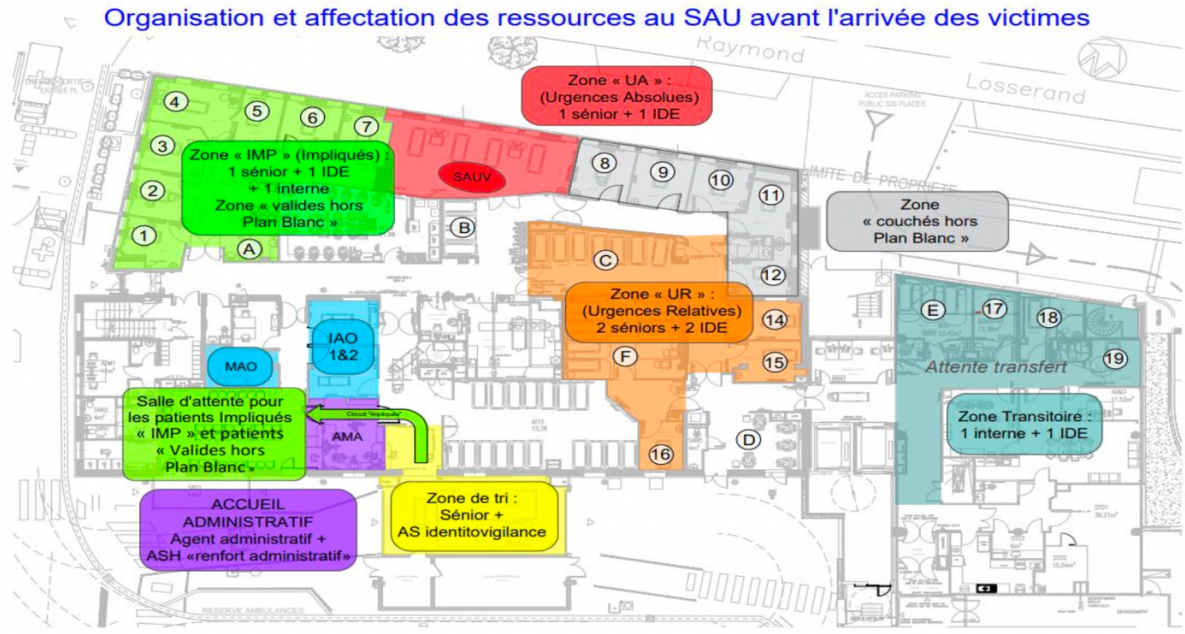
Afin de bien préparer les équipes, une organisation précise a été pensé par différents professionnels du service.

Lorsqu'un plan blanc (donc AMAVI) est déclenché, une organisation va rapidement se mettre en place, permettant ainsi de pouvoir accueillir le plus grand nombre de victimes.

Pour se faire, un médecin sera désigné « Médecin plan blanc » et il désignera à son tour un « Infirmier plan blanc », l'IDE plan blanc devra à son tour désigner les différents membres du personnel selon un ordre chronologique prédéfini et écrit sur sa fiche réflexe.

Chaque membre de l'équipe recevra une pochette contenant une fiche réflexe, la première chose à faire quand on reçoit sa fiche réflexe est : **LIRE SA FICHE REFLEXE ☺**

Ensuite, les urgences seront divisées en plusieurs zones (5 zones précisément) :



- ➔ Zone de tri = zone jaune = SAS pompier.
  - Entrée unique pour l'accueil des victimes
    - Personnel présent : 1 médecin + 1 AS
- ➔ Zone d'accueil = zone violette = accueil administratif.
  - Inscription des victimes + vérification des identités
    - Personnel présent : 1 agent administratif + 1 ASH
- ➔ Zone IOA / MAO = zone bleue
  - Personnel présent : 1 Médecin + 2 IDE (1/IOA) + 1 AS.
- ➔ Zone impliquée = zone verte = zone 1
  - Prise en charge des victimes impliquées.
    - Personnel présent : 1 médecin + 1 interne + 1 IDE + 1AS.
- ➔ Zone UR (urgences relatives) = zone orange = espace C + F et box 14, 15 et 16.

- Prise en charge des victimes triés « urgence relative » par le médecin de tri.
  - Personnel présent : 2 médecins + 2 IDE + 1 AS.

➔ Zone UA (urgence absolue) = zone rouge = SAUV

- Prise en charge des victimes triés « urgence absolue » par le médecin de tri.
  - Personnel présent : 2 médecins + 2 IDE + 1 AS.

➔ Zone Transitoire = zone bleu/vert = zone 2B (espace E + boxes 17, 18, 19).

- Prise en charge des patients présents aux SAU avant le déclenchement du plan blanc.
  - Personnel présent : 1 médecin + 1 IDE

En fonction du rôle qui vous a été désigné par « l'IDE plan blanc » vous serez donc affecté à une zone et vous recevrez une fiche réflexe.

Nous vous les présentons ci-dessous, elles ne sont pas à connaître par cœur, mais plus vous les maîtriser, plus vous serez à l'aise dans le cas d'un déclenchement.

FICHE REFLEXE « IDE PLAN AMAVI »

HÔPITAUX Paris
Saint Joseph Marie Lannelongue

Plan blanc – Fiche réflexe

14/10/2024

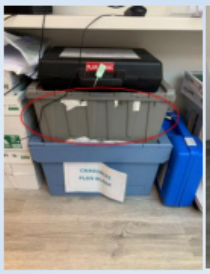
Missions de l'IDE Plan Blanc – (DECT : 7158)

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES ET DES RENFORTS

CHASUBLE BLEUE

☐ **Rassembler tout le monde dans le poste de soins (+ équipe LP : ASH, AS, IDE)**
☐ Prévenir l'accueil au 3458 ou 5093
☐ Appeler le **5454** et demander l'**affectation immédiate de deux brancardiers aux urgences**
➔ Remettre à chaque brancardier sa fiche reflexe à son arrivée dans le service

☐ **Ouvrir la mallette « Plan Blanc » + Mallette « Chasubles »**
☐ **Afficher le plan des urgences**
☐ **Désigner les rôles et donner les fiches réflexes comme suit :**
1 – Désigner 1 AS « Plan Blanc » ET 1 Externe
2 – Désigner 2 ASH « renfort-administratif »
3 – Désigner 1 AS « Identitovigilance » + Ouvrir malle « AS IDENTITOVIGILANCE » et prendre les pochettes « Dossier patient », à mettre à l'accueil
4 – Désigner 1 IDE UA (SAUV)
5 – Désigner 1 IDE UR (Zone 2A)
6 – Désigner 1 IDE Impliqué (Zone 1)
7 – Désigner 1 IDE Zone transitoire (Zone 2B)
8 – Désigner 1 AS par zone (UA + UR + Impliquée)
9 – Désigner 1 ou 2 IDE IOA
10 – Désigner 1 AS LP (80.45)
11 – Désigner 1 IDE LP (80.43) + 1 ASH LP (32.15)
13 – Désigner 1 IPA (81.28)
14 –Désigner 1 IDE psy (76.77)
15 – Appel secrétaire (77.58) et AMA (53.10 / 39.49 / 74.52)



☐ Alerter les cadres du service :
Mélanie Luce DECT : 7657 / Portable : 06 50 60 88 95
Ericka MARTIAL DECT : 80.21 / Portable : 06 04 96 79 74
Cadre de nuit 67.12

☐ Transmettre ses patients en cours de prise en charge à l'IDE zone transitoire
☐ Contrôler le port de la chasuble + pochette avec matériel par tous selon la zone de soins Plan blanc :
Impliqués : **vert** ; Urgences Relatives : **orange** ; Urgences Absolues : **rouge**
*Les médecins et internes doivent porter une chasuble « **Médecin** »*
☐ **Contrôler la présence du matériel dans chaque zone (registre, paper board) et la présence des rolls**
☐ Appeler en renfort les IDE selon les effectifs prévus, répartir les effectifs paramédicaux + DECT selon le tableau ci-joint et l'écrire sur le plan
☐ Afficher la feuille d'émargement des renforts à l'accueil administratif du SAU, avec l'heure d'arrivée
☐ Dès l'arrivée d'un encadrant paramédical du SAU, lui faire un état des lieux et se positionne en zone 2 pour prendre en charge les **patients hors Plan Blanc.**

FICHE REFLEXE « IOA »

HÔPITAUX Paris
Saint Joseph Marie Lannelongue

Plan blanc – Fiche réflexe

14/10/2024

Missions de l'Infirmier d'Orientation et d'Accueil

AVANT l'ARRIVEE DES VICTIMES

☐ Lire sa fiche réflexe

Si 1 IOA :
☐ Se positionner dans le box IOA 1 (DECT 6190)

Si 2 IOA :
☐ IOA 1 = Box IOA 1 (DECT 61.90)
☐ IOA 2 = Box IOA 2 (DECT 61.91)

☐ **Mettre en place affichage sur les portes des IOA**

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

Si 1 IOA :
☐ Voit les patients hors plan blanc + **victimes impliquées**.
Si 2 IOA :
→ **IOA 1**
☐ Voit **uniquement** les patients **hors plan blanc**
→ **IOA 2**
☐ Voit **uniquement** les **victimes impliquées**.

Les Urgences relatives et Urgences Absolues sont accueillies directement par les IDE des zones de prise en charge Plan Blanc après être passées par la zone de tri dans le SAS pompiers

☐ Questionnaire « IOA Plan Blanc » dans DxCare pour les **victimes impliquées** (remplir en priorité les champs rouges)

☐ Questionnaire habituel pour tous les autres patients

☐ Orienter les patients selon leur zone de prise en charge :
Patients hors Plan Blanc :
- Box 8 à 12 pour le circuit couché
- zone 1 pour le circuit valide

Patients « Impliqués » : zone 1

1URG-INFO-059

FICHE REFLEXE « MISSIONS DES IDE DES DIFFERENTES ZONES : IMP / UR / UA »

HÔPITAUX Paris
Saint Joseph Marie Lannelongue

Plan blanc – Fiche réflexe

14/10/2024

Missions des IDE des différentes zones : IMP / UR / UA

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES ET DES RENFORTS

- ☐ **Lire sa fiche réflexe**
- ☐ **Se positionner dans sa zone**
- ☐ Prendre sa chasuble : **UA (rouge)** / **UR (orange)** / **Impliqué (vert)**
- ☐ Prendre son DECT :
  - UA : 72.77
  - UR : 73.37
  - IMP : 73.71
  - Transitoire : 83.29

- ☐ Récupérer le registre de la zone de soins dans la mallette Plan blanc
- ☐ Vérifier la présence du paper board et du matériel
- ☐ Inscription de chaque patient pris en charge dans cette zone

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

- ☐ **Inscription de chaque patient pris en charge dans cette zone**
- ☐ **Coller étiquette « Plan Blanc » + SINUS avec heure d'entrée dans le registre et sur le paper board.**
- ☐ Prise en charge du patient avec la feuille de prescription – pancarte transmission (disponible dans la pochette d'identification)
- ☐ Bons « demande d'imagerie » et de « prélèvements sanguins » présent dans la pochette du patient.
- ☐ Aider l'ASH à recueillir les données administratives des patients de la zone

Si recueil impossible : renseigner le verso (signes distinctifs) pour permettre à la cellule d'identitovigilance de renseigner la préfecture de police

- ☐ Inscrire l'heure de sortie du patient + destination sur le registre de la zone

A L'ARRIVEE DES RENFORTS

- ☐ A l'arrivée des renforts, suivre la répartition des effectifs selon décision IDE Plan Blanc

[Ne pas supprimer ce texte]

FICHE REFLEXE « MISSIONS DE L'IDE DE LA ZONE TRANSITOIRE »

HÔPITAUX Paris
Saint Joseph Marie Lannelongue

Plan blanc – Fiche réflexe

14/10/2024

Missions de l'IDE Zone Transitoire (DECT : 83.29)

CHASUBLE GRISE

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES ET DES RENFORTS

- ☐ **Lire sa fiche réflexe**
- ☐ **Se positionner dans sa zone**
- ☐ Prendre son DECT : **8329**

- ☐ Prendre les transmissions des patients déjà aux urgences
- ☐ Se positionner dans sa zone : E, box 17, 18, 19, couloir
- ☐ Organiser la zone :
  - Zone E et couloir pour les patients à hospitaliser
  - Box 17-18-19 pour les patients moribonds
- ☐ Tableau velleda pour décompte des victimes
- ☐ Registre de décompte des patients présents
- ☐ Faire monter dans les étages les patients transmis hors plan blanc (en lien avec le gestionnaire de lits)
- ☐ Prise en charge des patients hors plan blanc (après transfert des autres)

ORGANISATION DU TRANSFERT DES PATIENTS VERS LES ETAGES

Envoyer les patients 2 par 2, en respectant l'ordre suivant :

1- **Rhumatologie/Médecine interne** (P14 N1) – DECT : **38.60(R)/ 68.25(MI)** – **Cadre 78.01**
2- **Urologie** (NDBS N2) – DECT : **38.34** – **Cadre 79.35**
3- **Médecine vasculaire** (St Vincent N1) – DECT : **37.62** – **Cadre 72.55**
4- **ORL / Proctologie / CMF** (P5 N1) – DECT : **34.34** – **Cadre 69.12**
5- **Pneumologie** (P14 N3) – DECT : **33.92** – **Cadre 78.71**
6- **Gynécologie / plastique** (NDBS N4) – DECT : **81.40** – **Cadre 79.35**
7- **Chirurgie vasculaire** (P6 N1) – DECT : **74.94** – **Cadre 79.18**
8- **Chirurgie digestive** (P5 N2) – DECT : **76.88** – **Cadre 72.97**
9- **Médecine interne** (P14 N4) – DECT : **71.30** – **Cadre 78.48**
10- **Orthopédie** (P5 N3) – DECT : **38.63** – **Cadre 77.96**
11- **Médecine vasculaire** (Saint Vincent N2) – DECT : **72.73** - **Cadre 72.55**
12- **Oncologie** (P14 N5) – DECT : **83.41** – **Cadre 69.39**
13- **Gastro-entérologie** (P1 N2) – DECT : **31.88** – **Cadre 72.97**
14- **Diabétologie** (P2 N2) – DECT : **39.58** – **Cadre 78.39**
15- **Orthopédie** (P1 N3) – **DECT : 32.04** - **Cadre 77.96**
16- **Médecine vasculaire** (Saint Vincent N3) – DECT : **32.70** - **Cadre 72.55**
17- **Suites de couche** (NDBS N5) – DECT : **81.50** – **Cadre 80.73**
18- **Suites de couche** (NDBS N6) – DECT : **81.60** – **Cadre 80.73**

WEEKEND - CADRE 73.31 et 67.12

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

- ☐ PEC des patients moribonds

FICHE REFLEXE « IDE DES LITS D'URGENCES »

HÔPITAUX Paris Saint Joseph Marie Lannelongue

Plan blanc – Fiche réflexe

14/10/2024

Missions de l'IDE LP – (DECT : 80.43)

CHASUBLE ROUGE

AVANT L'ARRIVÉE DES VICTIMES

- ☐ **Lire sa fiche réflexe**
  - ☐ **Lire sa fiche réflexe**
  - ☐ **Se positionner à la SAUV (zone UA)**
  - ☐ Prendre sa chasuble : **UA (rouge)**
  - ☐ Prendre son DECT : 80.45
- ☐ Vérifier la présence du registre de la zone de soins.
- ☐ Vérifier la présence du paper board et du matériel
- ☐ Inscription de chaque patient pris en charge dans cette zone

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

- ☐ **Inscription de chaque patient pris en charge dans cette zone**
- ☐ **Coller étiquette « Plan Blanc » + SINUS avec heure d'entrée dans le registre et sur le paper board.**
- ☐ Prise en charge du patient avec la feuille de prescription – pancarte transmission (disponible dans la pochette d'identification)
- ☐ Aider l'ASH à recueillir les données administratives des patients de la zone

  Si recueil impossible : renseigner le verso (signes distinctifs) pour permettre à la cellule d'identitovigilance de renseigner la préfecture de police

- ☐ Inscrire l'heure de sortie du patient + destination sur le registre de la zone

A L'ARRIVÉE DES VICTIMES

- ☐ A l'arrivée des renforts, suivre la répartition des effectifs selon décision IDE Plan Blanc et/ou de la cadre

3. NRBC-E

Le plan NRBC est un des 5 plans opérationnels de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles (**ORSAN**) :

AMAVI	EPI-CLIM	REB	NRC	MEDICO-PSY
Accueil massif de victimes non contaminées d'un événement grave	PEC des tensions dans l'offre de soins liées au nombre important de patients suite à une pandémie saisonnière et/ou lors d'un phénomène climatique, voire environnemental important	PEC des patients dans le cadre du risque épidémique et biologique connu ou émergent	PEC des patients dans le cadre d'un risque nucléaire, radiologique ou chimique	PEC médico-psychologique des patients victimes d'un événement grave
Catastrophe naturelle *Accident technologique* *Attentats avec armes de guerre et/ou engins explosifs*	*Canicules* *Grand froid*	*COVID* *EBOLA* *H5N1*	*Usine ASF (Toulouse)* *Tchernobyl / Fukushima*	*Accident, Catastrophe, Attentat*

Il existe 3 types de risques :

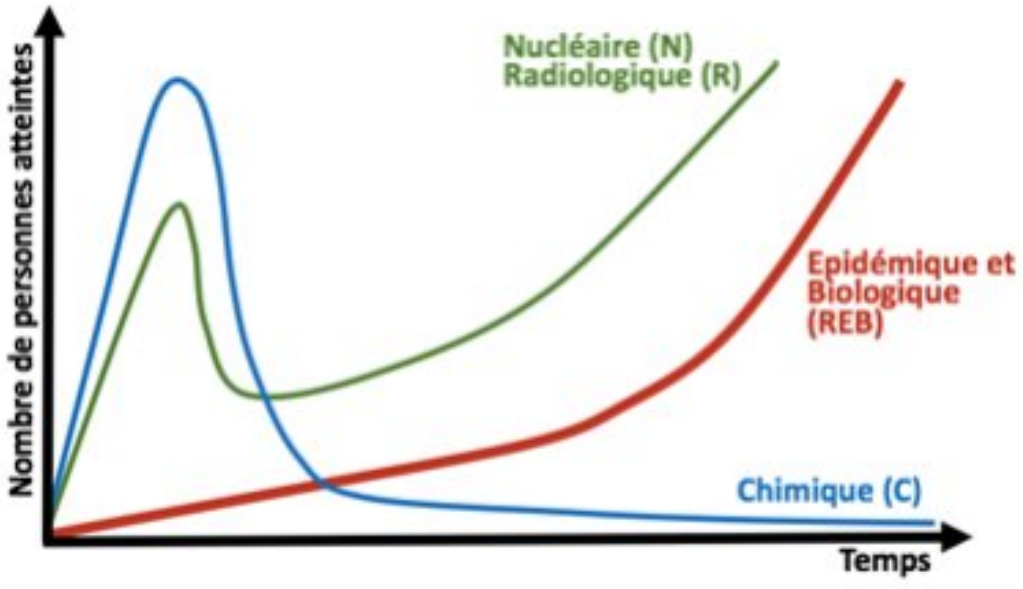


Figure 1 Cinétique comparée des SSE liées à un agent NR-REB-C

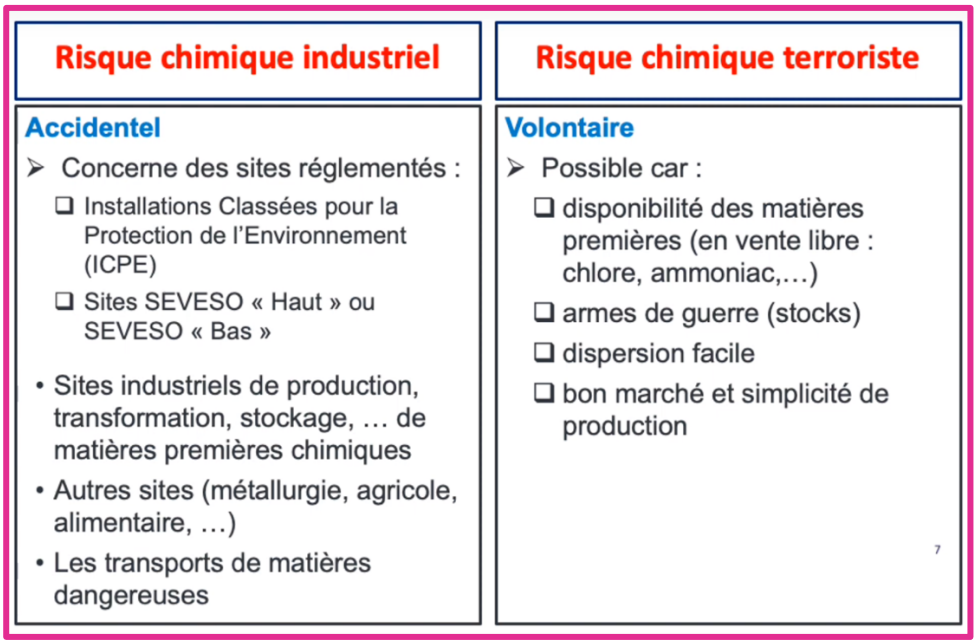
1. Le risque chimique :

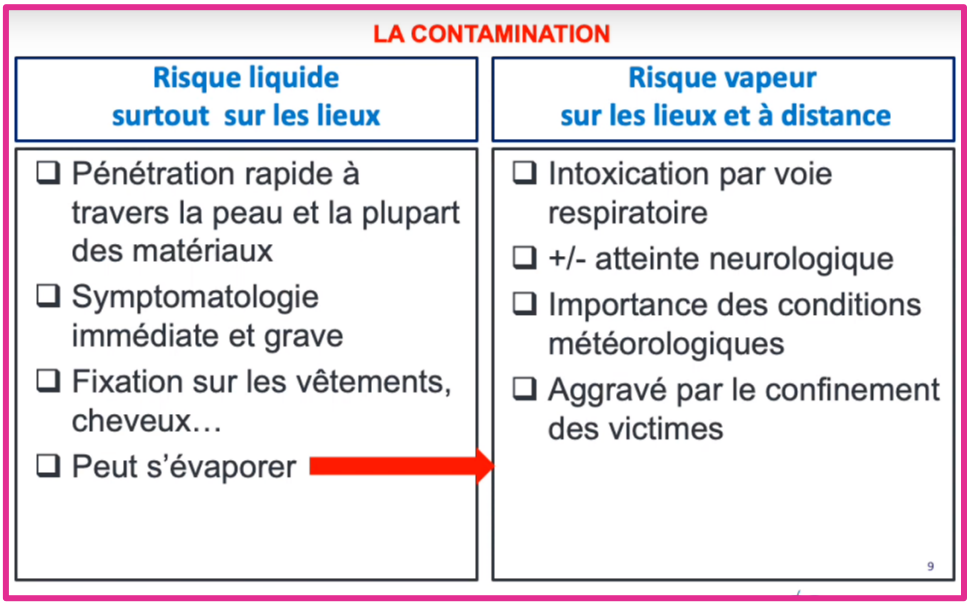
L'exposition au toxiques chimiques peut-être accidentel ou à la suite d'un acte malveillant (toxique industriel ou de guerre).

Quelques exemples :

- Seveso – Italie (1976) : explosion d'un réacteur et dissémination de dioxine (220 000 personnes exposées).
- Bhopal – Inde (1984) : explosion d'une usine de pesticides, 40 tonnes d'isocyanate de méthyle (4000 morts et 360 000 victimes).
- Toulouse – France (2001) : AZF, explosion d'un stock de nitrate d'ammonium (31 morts et 2500 blessés).

La dispersion d'un produit chimique toxique peut-être accidentelle ou volontaire. Le produit chimique toxique peut-être sous forme liquide « risque liquide » ou sous forme de gaz « risque vapeur ».





Cartographie des produits chimiques toxiques :

LES SUFFOCANTS

Chlore, phosgène → GAZ non persistant, odeur herbe fraichement coupée, Inhalation par les voies respiratoires, hydrolyse en HCl + CO2 --> OAP +SDRA

Clinique
Intervalle libre 2-36h

- Irritation yeux et des VAS avec oppression thoracique.

PUIS

- OAP lésionnel + SDRA, hypoxie, cyanose, collapsus HD

Traitement
Aucun antidote spécifique

Traitement symptomatique

- Soustraire de la zone toxique
- O2, β2-mimétiques
- VS-PEP voire IOT

Décontamination approfondie : NON

LES DERIVES CYANES

Toxiques cellulaires, GAZ non persistant, odeur amande amère, inhalation par voies respiratoires ++

Clinique

Selon la concentration d'exposition

- Céphalées, agitation, vertiges, convulsion, mydriase, coma
- Dyspnée, constriction thoracique
- Collapsus cardiovasculaire , arrêt cardiaque en quelques minutes

Traitement

Traitement symptomatique

- Soustraire de la zone toxique
- O2, correction troubles hémodynamiques, anticonvulsivants

Traitement spécifique

➢ **CYANOKIT 5g** (70 mg/kg) à renouveler 1 fois à 15 min si besoin. Pas d'EI.

Décontamination approfondie : OUI

LES VESICANTS : YPERITE AU SOUFFRE

Liquide huileux → GAZ incolore, odeur ail/moutarde. Persistant. Atteinte cutanéo-muqueuse. → **Ypérité = patient brûlé immunodéprimé.**

Clinique

Pas de symptômes immédiats

- Prurit/érythème (H2-12) puis phlyctènes (H12-48)
- Larmoiement/brûlure oculaire légère (H4-H12) ;
- Douleur intense, conjonctivite, œdème, cécité transitoire (H1-2) **si concentration importante**

Traitement

Pas de traitement spécifique

PEC symptomatique

- Analgésie
- Lavage oculaire
- Traitement des brûlures

Décontamination approfondie : OUI

LES VESICANTS : LEWISITE

État liquide/Gaz incolore, odeur de géranium, Persistant.

Clinique

- **Sensation de brûlure immédiate** (peau, VAS, yeux)
- Zones grisâtres sur la peau, lésions profondes douloureuses.
- Atteinte pulmonaire (OAP), hépatique, rénale, intestinale et neurologique

Traitement

- **PEC symptomatique** (analgésie, lavage oculaire, ttt brûlures…)
- **Antidote spécifique :**

➢ **BAL 2-3 mg/kg IM précoce** puis toutes les 4h pendant 2j

Décontamination approfondie : OUI

LES NEUROTOXIQUES ORGANOPHOSPHORES

Agents G et agents V., pesticides → Gaz persistant + dense que l'air. Pénétration cutanée et aérienne, **neurotoxique ++ par inhibition de l'hydrolyse de l'Ach.**

Clinique

Syndrome muscarinique, nicotinique et central

→ **HYPOXIE**

- Bronchospasme, hypersécrétions +++ détresse respiratoire
- Myosis, convulsion, coma
- Nausées, vomissements
- Hypotension, bradycardie, arrêt cardiaque

Décontamination approfondie : OUI

LES NEUROTOXIQUES ORGANOPHOSPHORES

Traitement

- **Aspiration, oxygénothérapie**

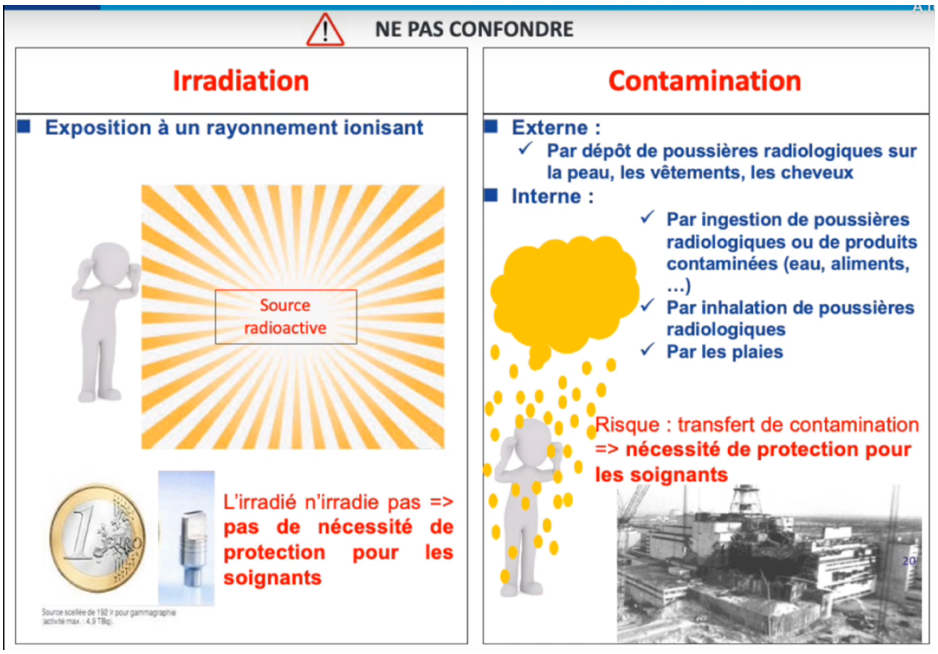
- **AIBC INEUROPE IM**
- **Contrathion**
  - 200 mg en IVL à 2g IVL si forme grave
  - Entretien : 400 mg 30min puis 200 mg/4-6h

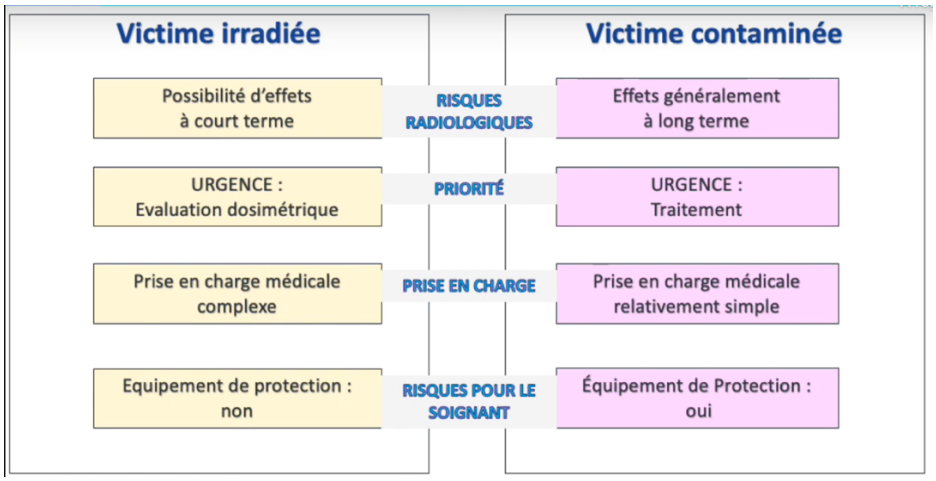
- **Atropine IV**
- 2 mg à renouveler en doublant les doses (2-4-8-16 mg…) jusqu'à assèchement des muqueuses, levée du bronchospasme et normalisation de la FC. Entretien 1.5 à 6 mg/h
- **Anticonvulsivants**
  - **Diazepam** en préventif : 10 mg IM/IV, à renouveler si besoin
  - **Clonazepam** si convulsion 1-3 mg IV puis entretien 0,1-0,5 mg/h IVSE
  - **Midazolam** si convulsion 5-10 mg IV puis entretien 5-10 mg/h IVSE

Décontamination approfondie : OUI

2. Le risque nucléaire, radiologique :

Important : l'urgence médico-chirurgicale prime sur l'urgence radiologique.





ACCIDENT DE CONTAMINATION

- **Confiner la contamination** (pansement occlusive, vinyle, EPI)
- **Ne pas transformer une contamination externe en contamination interne**
- **Traitement de la contamination interne au plus vite ++**

➢ **DTPA Ca IV** ½ ampoule, aérosol ou cutané selon la contamination ; **Chélateur spécifique**

Décontamination approfondie : OUI

ACCIDENT PAR IRRADIATION

Un irradié n'irradie pas !

- **Distinguer une irradiation globale/localisée**
  - Syndrome d'irradiation aigu (dose dépendant)
  - Brûlure radique (dose dépendant)
- **Priorité au diagnostic (dosimétrique)**

Décontamination approfondie : NON

3. Le risque biologique :

C'est l'exposition à des agents pathogènes pouvant entrainer une contamination, des syndromes infectieux, des épidémies ou des pandémies.

Quelques types d'agents pathogènes :

- Virus : varioles, grippe, ...
- Bactéries : anthrax, peste, ...
- Toxines : botulisme, ricine, ...

Le risque biologique peut-être dû à :

- Une cause naturelle : maladie d'origine naturelle, maladie infectieuse émergente (COVID) ou ré-émergente (variolle).
- Une cause accidentelle : conséquence imprévue de la recherche, accident de laboratoire, manque de sensibilisation, négligence.
- Une cause intentionnelle : emploi délibéré (par un état, par un « acteur » non étatique) = Bioterrorisme.

En France et dans le monde, les agents microbiologiques sont classés. Les USA utilisent la classification C.D.C (Centers for Disease Control and Prevention) en 3 groupes, A, B et C. En France, nous avons classées les agents biologiques en quatre groupes « 1, 2, 3, et 4 » en fonction de la gravité croissante du risque d'infection qu'ils représentent pour l'homme.

La contamination se fait soit par :

- Inhalation : aérosol, poudre
- Ingestion : aliments, boissons, eau courante contaminée
- Contact : avec la peau ou les muqueuses.

Prise en charge du risque biologique :

- Détection rapide des phénomènes anormaux.
- Prévention de la transmission nosocomiale.
- Contre-mesures adaptées (traitements, vaccins, EPI, tests diagnostiques).
- Circuits et organisations fléchés, maîtrise de la communication.
- → PEC thérapeutique = fiche BIOTOX spécifiques.

Aux urgences :

Comme pour la partie AMAVI, la partie NRBC a été pensé de la même façon. Ainsi, une organisation particulière se mettra en place dans le service. Le grand changement est surtout au niveau de l'extérieur du service, avec la décontamination des victimes et des soignants de première intention. A l'intérieur des urgences, nous reprenons l'organisation du plan AMAVI.

Les patients devront être déshabillés dehors, puis douchés les uns après les autres, puis habillés et ensuite triés et pris en charge dans une zone des urgences.

AVANT TOUTE CHOSE : DETECTER ET ALERTER

Si plus de 2 patients ayant fréquenté la même zone géographique avec des symptômes similaires (difficultés respiratoires, cutanées, oculaires, ect ...) → suspicion d'une attaque NRBC.

Mise en place de la chaîne de survie, étape par étape = DUST-DAHO (à l'hôpital, seulement le DUST-DA).

1) Décontamination d'Urgence :

- **Habillage des intervenant avec équipement personnel de protection (EPI)**
- **Extraire les patients de la zone de danger; les rassembler à l'AIR LIBRE (PRV);** triage visuel rapide
- **Consignes pour réaliser la DU (éviter dispersion de l'agent) avec kit décontamination:**
  - Protéger les VAS, retirer la première couche de vêtements et chaussures.
  - Utilisation de gants poudreurs
  - **Ne pas boire, manger ou fumer** jusqu'à nouvel ordre

2) Symptômes :

- **Identification rapide de l'agent contaminant**
  - Contexte
  - Signes cliniques
  - Résultats obtenus par appareils de détection

  → Identification faite par les SP ou équipes spécialisées NRBC

- **Évaluation clinique rapide du malade**
  - START-ABC; MARCHE

  → Triage rapide des malades

3) Traitements :

EVITER LES MORTS EVITABLES

- Prise en charge selon les principes du DAMAGE CONTROL
- Administration de traitements et d'antidotes spécifiques au PRV dès les 1ers symptômes.

  Pas de traitement per os

  →Rôle de stabilisation par les soignants

  → Gestes effectués doivent être équipes médicales/victimes compatibles

4) Décontamination approfondie :

- Prise en charge des victimes contaminées sans tenues de protection
- Indispensable pour les agents chimiques persistants, radionucléides dispersés et certains agents biologiques
- Décontamination EAU+SAVON , améliore le pronostic individuel
- Permet évacuation zone de soutien et PMA

5) Évacuation vers l'hôpital (seulement en extrahospitalier) :

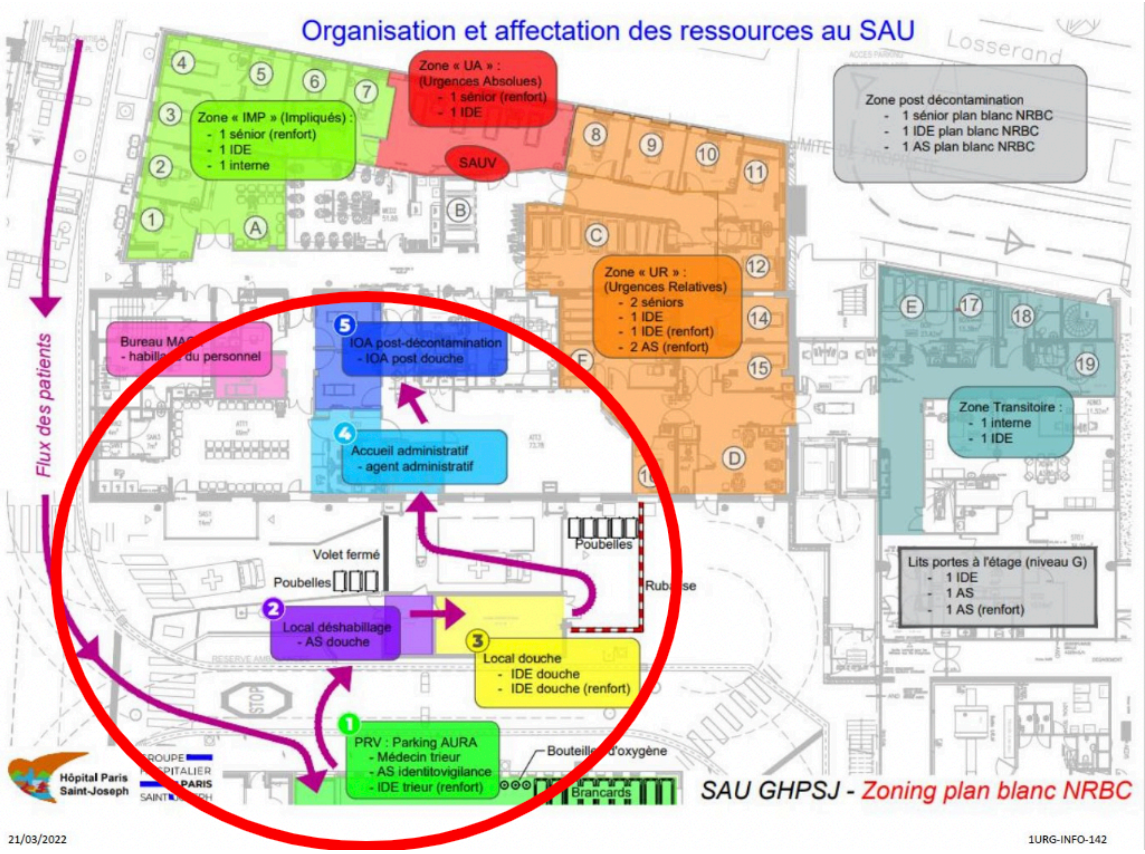
- Evacuation vers les établissements de santé de 1ère et 2e ligne pour prise en charge médicale.
- Décontamination préhospitalière selon l'agent et gravité du malade
- **En cas d'urgence médico-chirurgicale chez un patient radio-contaminé :**
  → L'urgence médico-chirurgicale prime !

En cas d'arrivée de victimes dans la salle d'attente, les agents d'accueil sont formés à savoir repérer les signes d'alertes, en cas de présentation de 2 à plusieurs personnes avec les mêmes symptômes à quelques minutes d'intervalles ET ayant fréquenté le même lieu-zone géographique.

Conséquence : toute la salle d'attente valide est contaminée, aucun patient ne doit rentrer dans les urgences, décontamination obligatoire.

Conduite à tenir : Faire sortir tout le monde dehors (vider entièrement la salle d'attente) à l'air libre → mise en place du point de rassemblement des victimes (PRV). Les équipes s'habille avec les EPI.

Le plan NRBC :



Par rapport au plan, un petit changement, les patients attendrons devant les urgences (juste devant l'entrée du sas pompiers).

Les flèches de couleur violette représentent le circuit du patient de son entrée dans l'enceinte de l'hôpital.

Habillage en tenue de protection :

MEDECIN et IDE TRIEUR

- Habillage en tenue C3P
- Positionnement au PRV
- Séparation des valides et non-valides
- Tri UA-UR-IMP et organisation du passage à la douche
- Réalisation des soins / damage control

AS IDENTITOVIGILANCE

- Habillage en tenue C3P
- Positionnement au PRV
- Donner jeu d'étiquettes d'identification + sac poubelle
- Régulation local déshabillage
- Rappeler les consignes
- Rassurer les patients

Retrouve la vidéo de l'habillage du déshabillage en flashant les QR Codes suivants :

Pendant ce temps, pour les victimes :

Distribution de kits permettant aux victimes de se déshabiller et de se préparer pour la douche de décontamination. Dans chaque kit, la victime reçoit une fiche explicative :

Puis passage à la douche un à un, avant de s'habiller en tenue hospitalière et d'être pris en charge par les équipes soignantes présentes dans les urgences.

FICHE REFLEXE « L'IDE NRBC » :

GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH — Hôpital Paris Saint-Joseph

Fiche réflexe - NRBC

Missions de l'IDE NRBC Tel 7337

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES ET DES RENFORTS

☐ Prévenir l'accueil au 3458 ou 5093

☐ Appeler le 5454 et demander l'**affectation immédiate de deux brancardiers aux urgences**

➔ Remettre à chaque brancardiers sa fiche reflexe et leur demander de transférer les patients desurgences et lits portes vers les services

➔Rapporter des brancards, des fauteuils roulants et les mettre à l'accueil des urgences puis se mettreà disposition du senior trieur qui se trouve dans le PRV

☐ Alerter les cadres du service :

Constance Frechet : 8021 06[redacted] / Bernadette Gauchet : 7657/ 06 [redacted]

☐ Désigner 1 **AS « Identitovigilance NRBC »** et lui remettre sa fiche réflexe

Dès l'arrivée des premiers patients, l'AS Identitovigilance reste avec le sénior dans le PRV

☐ Désigne 1 AS douche UDH + IDE douche UDH en journée

☐ Dirige le médecin et l'IDE trieurs vers le MAO pour leurs habillages

☐ Noter l'heure de début d'habillage du médecin et IDE trieurs sur fiche de suivi personnel

☐ Désigner 1 **AS « Plan Blanc »** et lui remettre sa fiche réflexe.

➔ Accompagné(e) d' 1 ASH, l'AS va chercher : les 3 rolls «Plan Blanc» de pharmacie + le roll lingerie + le rollsignalétique + 2 paper boards + le chariot de soins, prêts et stockés dans la réserve SAU :

niveau -1, sous les lits d'urgences 1 — *Digicode : C1267*

si besoin, récupérer le roll « Plan Blanc Pédiatrique »

➔Installer les rolls plan Blanc+ malle NRBC dans le couloir contre le mur de la zone F + Roll NRBC dans L'UDH

☐ Fais vider le local poubelle En journée par F. Doguet : 7695 / Nuit et We : Pc sécurité : 3665

☐ Transmettre ses patients en cours de prise en charge à ses collègues

☐ Désigner **1 ASH « renfort administratif »** et lui remettre sa fiche réflexe.

☐ Contrôler le port de la chasuble par tous selon la zone de soins Plan blanc :

Impliqués : chasuble **vert** ; Urgences Relatives : Chasuble **orange** ; Urgences Absolues : Chasuble **rouge**

*Les médecins et internes doivent porter une chasuble « **Médecin** »*

☐ Appeler en renfort les IDE du SAU selon les effectifs prévus et Répartir les effectifs paramédicaux + DECT selon le tableau ci-joint et l'écrire sur le plan

☐ Afficher la feuille d'émargement de l'heure d'arrivée des renforts à l'accueil administratif du SAU

☐ Dès l'arrivée d'un encadrant paramédical du SAU, lui fait un état des lieux et reprend ses fonctions initiales.

FICHE REFLEXE « L'IDE TRIEUR NRBC » :

GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH

Hôpital Paris Saint-Joseph

Fiche réflexe - NRBC

Missions de l'IDE trieur NRBC

CHASUBLE JAUNE

1- S'habille selon l'agent pathogène soupçonné (cf fiches) en binôme avec l'IDE trieur présent(e) en journée

2 - Se positionner au PRV (Point Rassemblement des Victimes)

3 - Séparer les victimes en deux groupes : victimes symptomatiques/victimes asymptomatiques

= Tri sommaire avec ordre de décontamination

4 - Demande aux victimes de ni boire ni manger ni fumer

5 - Etablie l'ordre de priorité de décontamination des victimes valides

6- Réalise les soins aux patients symptomatiques (O2, protection des VAS)

FICHE REFLEXE : MISSION DE L'IDE DOUCHE (A CREER)

4. CYBERATTAQUE

En cas d'arrêt/indisponibilité de DxCare non programmé (par exemple : panne ou coupure réseau) les prescriptions datant de moins de 24H et les prescriptions futures planifiées dans les 48H seront disponibles sous forme de fichier HTML.

Un fichier correspondant à un patient hospitalisé. Il n'y a pas de mode dégradé pour les patients venant pour une consultation.

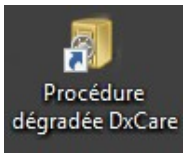
Ces fichiers seront accessibles via une icône sur le bureau des PC des postes de soins.

1. Prérequis :

- Le PC sur lequel est installé la procédure dégradée est identifié par la DSI (Étiquette de signalement + référencement) et la cadre du service.
  - Aux Urgences : PC à côté de la centrale de scope
  - Aux lits d'urgences : PC noter et trouver le PC
- Il doit rester allumé (même si l'écran est en veille). Des redémarrages réguliers sont toutefois à prévoir pour application des mises à jours de sécurité.
- Le PC doit être accessible.
- Le PC est relié à une imprimante branchée en port USB paramétrée par défaut.

2. Accès aux fichiers :

- Ouvrir votre session Windows sur le PC identifié
  - Aux Urgences : PC à côté de la centrale de scope
  - Aux lits d'Urgences : PC de hdjqjdhqjshdhqjdhq



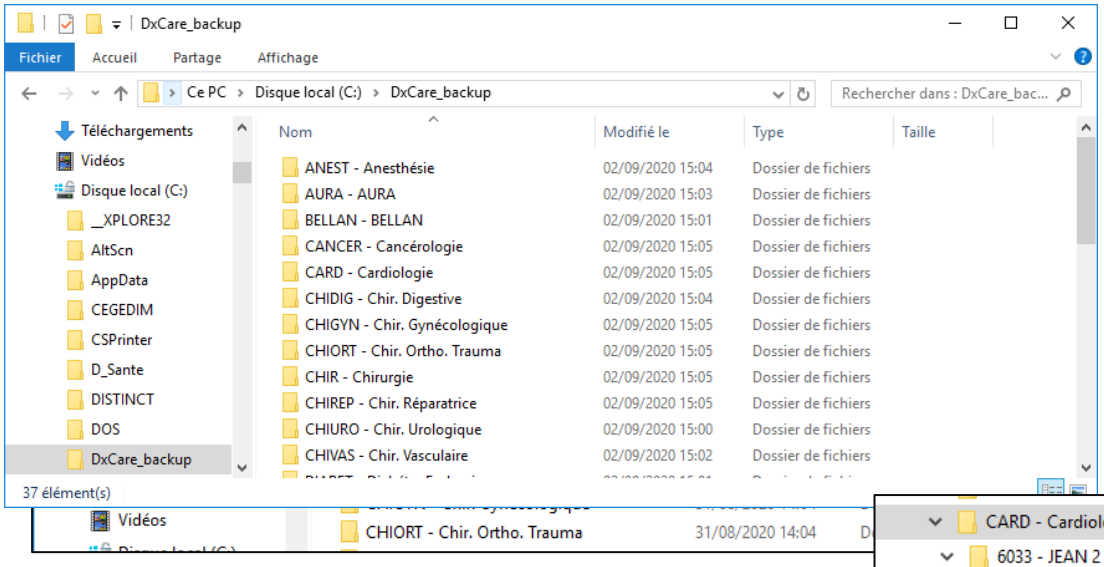
- Double-cliquer sur le raccourci « **Procédure dégradée DxCare** » du Bureau.

- Une fenêtre « **Explorateur de fichiers** » s'ouvre directement dans le partage ci-dessous :

➔ Un pop-up « **DxCare Dégradé** » s'ouvre, sélectionner alors le jour et l'heure de la sauvegarde à restaurer.

➔ Entrer LE MOT DE PASSE COMMUNIQUÉ PAR LA DSI

➔ Cliquer sur « **OK** », une fenêtre « **Explorateur de fichiers** » s'ouvre dans le dossier local C:\DxCare_backup.



3. Utilisation des fichiers :

➔ Ouvrir ensuite le répertoire de votre service (Spécialité de rattachement du patient) ;

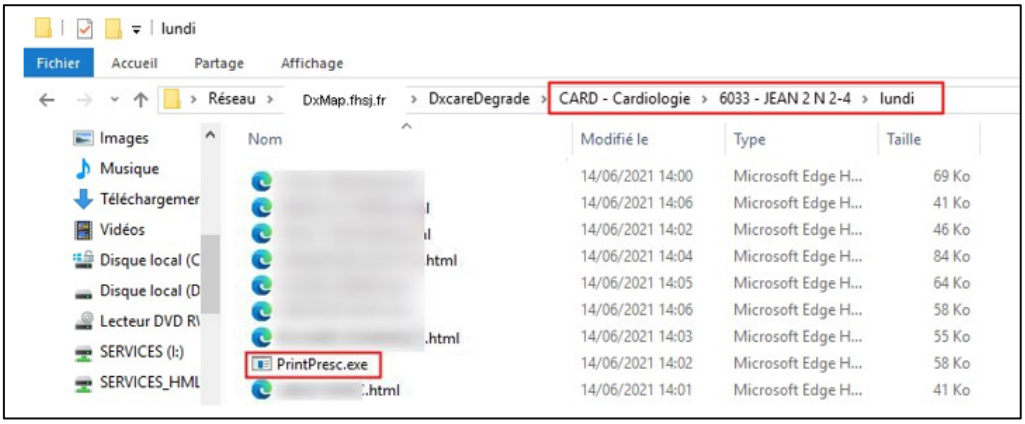
- Exemple ici CARD – Cardiologie (Il s'agit du service d'hébergement au moment du patient **au moment de la sauvegarde**).

- Puis le répertoire du **Poste de soins** (**Poste de traitement** du patient) ; exemple ici 6033 – JEAN 2 N 2-4

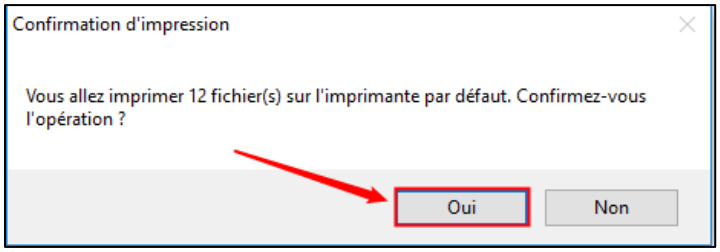
- Enfin le répertoire au **nom du jour de la semaine** de la panne ; exemple : *si l'on est mardi, ouvrir le répertoire* ***"mardi"***

Le répertoire contient :

- Des fichiers portant le nom de vos patients et qui contiennent les informations médicales de prescription.
- Un fichier nommé « **PrintPresc.exe** » (ou « **PrintPresc** »).

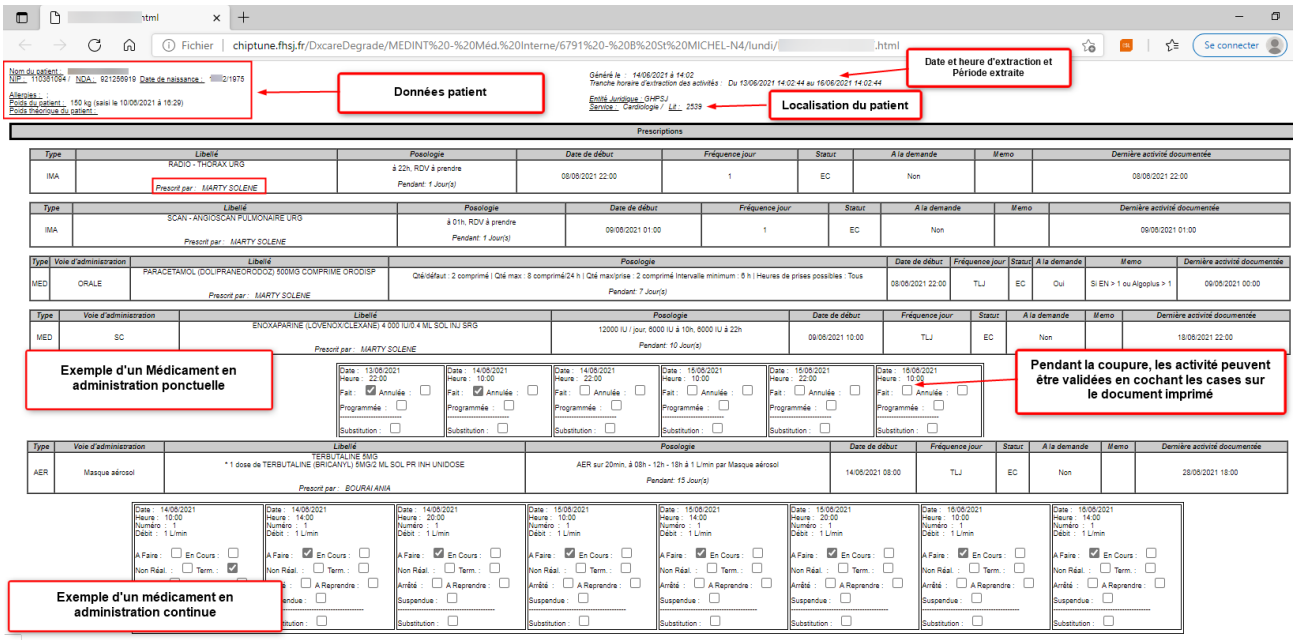


Pour imprimer l'ensemble des fichiers de tous les patients rattachés au poste de soins précédemmentsélectionné double-cliquer sur le fichier **printpresc.exe**. Un message s'affiche à l'écran.



Cliquer sur "**OUI**" pour lancer l'impression sur l'imprimante par défaut.

Voici l'exemple des fiches imprimées avec quelques explications :

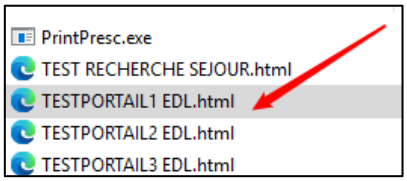


4. En cas de problème :

Si les « fiches patient » ne s'impriment pas ou mal veuillez **contacter le support informatique**

- Par téléphone (11 sur HSJ)
- Ou par mail (onze@ghpsj.fr)

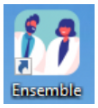
En attendant la résolution de ce problème, il reste possible de voir les prescriptions de vos patients directement à l'écran de votre PC en double cliquant que chaque fichier patient



A l'issue de la coupure, les administrations tracées sur papier pourront être scannées dans le dossier du patient, via la fonction Documents externes, en choisissant la catégorie DOSSIERS DE SOINS.

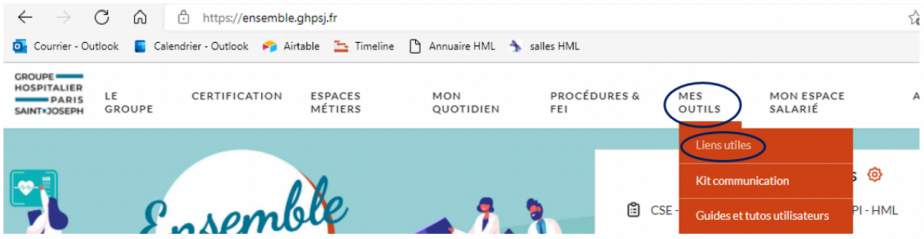
5. Accès aux autres applications :

DxCare permet via le menu Autres fonctions d'appeler d'autres applications de notre système d'information. Pour retrouver celles-ci il faudra, le temps de la coupure, passer via l'intranet Ensemble GHPSJ.

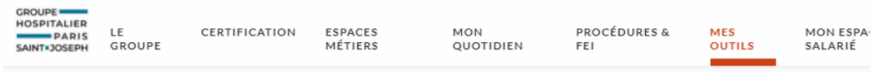


➔ Ouvrir l'intranet Ensemble GHPSJ via l'icône présente sur le bureau de votre PC, un navigateur internet s'ouvre

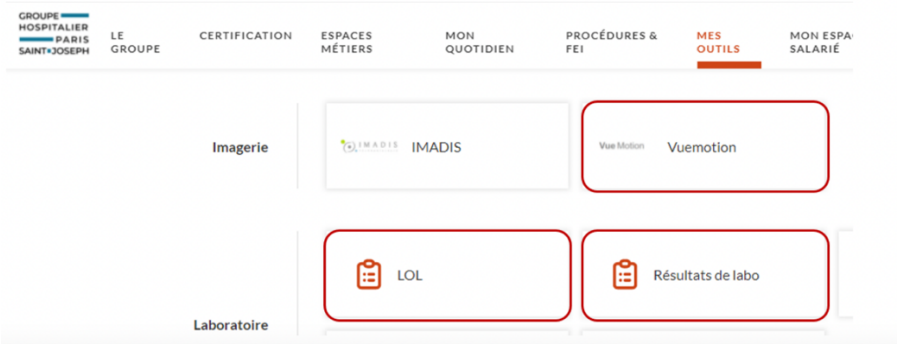
➔ Cliquer sur MES OUTILS, puis Liens utiles



➢ Descendre dans la liste des applications pour retrouver notamment les liens vers les logiciels d'imagerie et de laboratoire



➔ Descendre dans la liste des applications pour retrouver notamment les liens vers les logiciels d'imagerie et de laboratoire



PROCEDURE DEGRADEE : LABORATOIRE, IMAGERIE, BRANCARDAGE, ECG ET PHARMACIE :

→ Laboratoire :

Prélèvements techniques au laboratoire :

➔ La prescription est faite sur **Diagramme de soins procédure dégradée** (1URG-ENR-053)
➔ L'IDE rempli un bon papier et colle une étiquette manuscrite sur les tubes

Nom :
Prénom :
Nom de naissance :
DDN :
Sexe : H - F
Date admission : / /
SAU / Lits portes

Bon papier :

PHOTO

➔ Une bannette rouge « prélèvements à envoyer au laboratoire » est installée dans le poste de soins des Urgences pour centraliser les envois de bilans. L'AS du SAUV appelle le coursier toutes les 15 min si besoin pour qu'il achemine les bilans au laboratoire.

Photo

- Les bilans des patients du SAUV seront apportés directement par un membre de l'équipe du SAU au laboratoire.
- Les bilans des patients des Lits d'Urgences seront aussi déposés dans la bannette rouge du poste de soins.

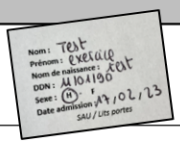
PAS D'UTILISATION DES PNEUMATIQUES EN PROCEDURE DEGRADEE

Prélèvements techniques aux urgences (PCR rapide) :

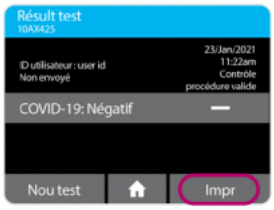
Pour les PCR rapides en procédure dégradée :

- Saisir manuellement dans la machine l'ID NOW le nom, prénom et date de naissance du patient
- Dans le cahier prévu à cet effet, collez l'étiquette manuscrite et renseigner le tableau (photo)
- Collez l'étiquette de résultats de PCR sur le tableau (photo)

Conduite à tenir en cas de panne de DxCare pour les ID NOW EBMD

Etiquette patient DxCare	Heure du test	Nom de l'IDE	Résultat COLLER ETIQUETTE RESULTAT PCR OBLIGATOIRE (négatif, positif ou invalide)	COLLER ETIQUETTE COVIDAL OBLIGATOIRE (redémarrage DxCare)	Remarques
	17h30	FREGHOT			

Pour imprimer le résultat de l'ID-NOW :



→ Pharmacie :

Bons d'urgences :

Sur le tableau blanc effaçable installé dans la SAUV, chaque personne ayant besoin d'un médicament ou d'un dispositif médical en urgence le note sur ce tableau.

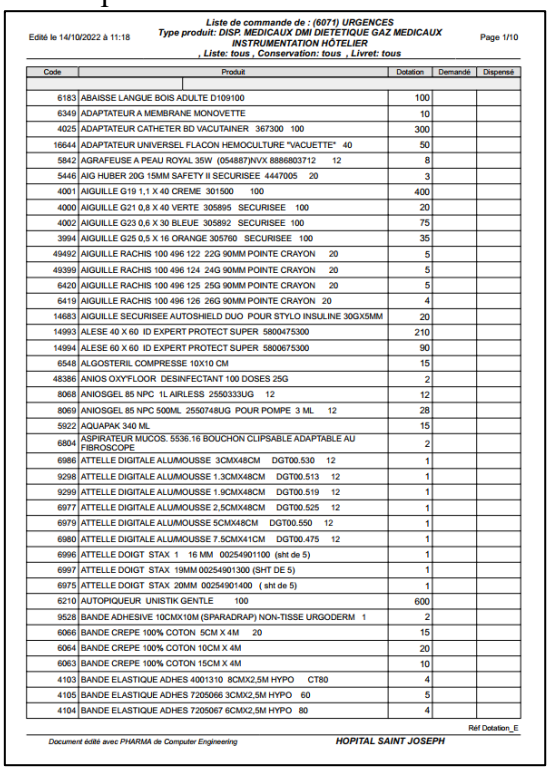
A 10h30 et à 15h, l'IDE référent des Urgences appelle la préparatrice en pharmacie pour faire la commande par téléphone.

De nuit (après 18h) ou en l'absence de l'IDE référent, l'IDE du SAUV se chargera de prévenir la pharmacie.

- **Médicaments : 53.80**
- **Dispositifs médicaux : 80.42**
- **Garde (Nuit et Week-end) : 77.05**

Commandes hebdomadaires :

Les listes des dotations en médicaments et en dispositifs médicaux (Urgences et Lits d'urgence) sont imprimées et mis dans un classeur Pharmacie procédure dégradée rangé dans le bureau des IDE référents.



Liste de commande de : (6071) URGENCES
Type produit: DISP. MEDICAUX DMI DIETETIQUE GAZ MEDICAUX INSTRUMENTATION HÔTELIER
, Liste: tous , Conservation: tous , Livret: tous

Edité le 14/10/2022 à 11:18 — Page 1/10

Code	Produit	Dotation	Demandé	Dispensé
6183	ABAISSE LANGUE BOIS ADULTE D109100	100		
6349	ADAPTATEUR A MEMBRANE MONOVETTE	10		
4025	ADAPTATEUR CATHETER BD VACUTAINER 367300 100	300		
16644	ADAPTATEUR UNIVERSEL FLACON HEMOCULTURE "VACUETTE" 40	50		
5842	AGRAFEUSE A PEAU ROYAL 35W (054887)NVX 8886803712 12	8		
5446	AIG HUBER 20G 15MM SAFETY II SECURISEE 4447005 20	3		
4001	AIGUILLE G19 1,1 X 40 CREME 301500 100	400		
4000	AIGUILLE G21 0,8 X 40 VERTE 305895 SECURISEE 100	20		
4002	AIGUILLE G23 0,6 X 30 BLEUE 305892 SECURISEE 100	75		
3994	AIGUILLE G25 0,5 X 16 ORANGE 305760 SECURISEE 100	35		
49492	AIGUILLE RACHIS 100 496 122 22G 90MM POINTE CRAYON 20	5		
49399	AIGUILLE RACHIS 100 496 124 24G 90MM POINTE CRAYON 20	5		
6420	AIGUILLE RACHIS 100 496 125 25G 90MM POINTE CRAYON 20	5		
6419	AIGUILLE RACHIS 100 496 126 26G 90MM POINTE CRAYON 20	4		
14683	AIGUILLE SECURISEE AUTOSHIELD DUO POUR STYLO INSULINE 30GX5MM	20		
14993	ALESE 40 X 60 ID EXPERT PROTECT SUPER 5800475300	210		
14994	ALESE 60 X 60 ID EXPERT PROTECT SUPER 5800675300	90		
6548	ALGOSTERIL COMPRESSE 10X10 CM	15		
48386	ANIOS OXY'FLOOR DESINFECTANT 100 DOSES 25G	2		
8068	ANIOSGEL 85 NPC 1L AIRLESS 2550333UG 12	12		
8069	ANIOSGEL 85 NPC 500ML 2550748UG POUR POMPE 3 ML 12	28		
5922	AQUAPAK 340 ML	15		
6804	ASPIRATEUR MUCOS. 5536.16 BOUCHON CLIPSABLE ADAPTABLE AU FIBROSCOPE	2		
6986	ATTELLE DIGITALE ALU/MOUSSE 3CMX48CM DGT00.530 12	1		
9298	ATTELLE DIGITALE ALU/MOUSSE 1.3CMX48CM DGT00.513 12	1		
9299	ATTELLE DIGITALE ALU/MOUSSE 1.9CMX48CM DGT00.519 12	1		
6977	ATTELLE DIGITALE ALU/MOUSSE 2,5CMX48CM DGT00.525 12	1		
6979	ATTELLE DIGITALE ALU/MOUSSE 5CMX48CM DGT00.550 12	1		
6980	ATTELLE DIGITALE ALU/MOUSSE 7.5CMX41CM DGT00.475 12	1		
6996	ATTELLE DOIGT STAX 1 16 MM 00254901100 (sht de 5)	1		
6997	ATTELLE DOIGT STAX 19MM 00254901300 (SHT DE 5)	1		
6975	ATTELLE DOIGT STAX 20MM 00254901400 (sht de 5)	1		
6210	AUTOPIQUEUR UNISTIK GENTLE 100	600		
9528	BANDE ADHESIVE 10CMX10M (SPARADRAP) NON-TISSE URGODERM 1	2		
6066	BANDE CREPE 100% COTON 5CM X 4M 20	15		
6064	BANDE CREPE 100% COTON 10CM X 4M	20		
6063	BANDE CREPE 100% COTON 15CM X 4M	10		
4103	BANDE ELASTIQUE ADHES 4001310 8CMX2,5M HYPO CT80	4		
4105	BANDE ELASTIQUE ADHES 7205066 3CMX2,5M HYPO 60	5		
4104	BANDE ELASTIQUE ADHES 7205067 6CMX2,5M HYPO 80	4		

Réf Dotation_E

Document édité avec PHARMA de Computer Engineering — *HOPITAL SAINT JOSEPH*

Date des commandes :

➔ Urgences : Lundi- Mercredi - Vendredi
➔ Lits d'Urgence : Lundi - Vendredi

Les Infirmiers référents remplieront le bon de commande pour les dispositifs médicaux et déposeront le bon rempli au guichet de la pharmacie.

Les préparateurs en pharmacie se chargeront de la commande des médicaments.

En cas de demande urgentes :

Forms via Office diffusé à tous les services par mail et saisie via son téléphone portable personnel

→ Imagerie :

A ECRIRE

→ ECG :

A ECRIRE

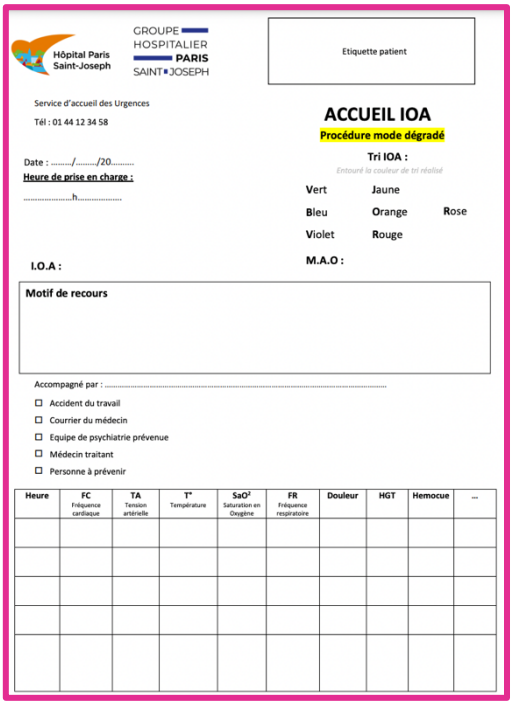
→ Brancardage :

A ECRIRE

6. PROCEDURE DEGRADEE- DOSSIER PAPIER

IOA

Recto



Hôpital Paris Saint-Joseph
GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT JOSEPH

Etiquette patient

Service d'accueil des Urgences
Tél : 01 44 12 34 58

ACCUEIL IOA
Procédure mode dégradé

Date : ...../...../20.....
Heure de prise en charge :
.....h.....

Tri IOA :
Entouré la couleur de tri réalisé
Vert Jaune
Bleu Orange Rose
Violet Rouge

I.O.A :
M.A.O :

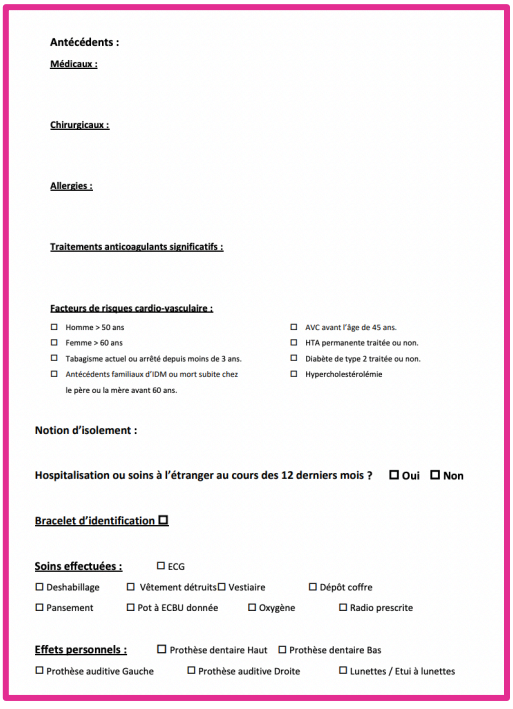
Motif de recours

Accompagné par : .....

- ☐ Accident du travail
- ☐ Courrier du médecin
- ☐ Equipe de psychiatrie prévenue
- ☐ Médecin traitant
- ☐ Personne à prévenir

Heure	FC Fréquence cardiaque	TA Tension artérielle	T° Température	SaO^2 Saturation en Oxygène	FR Fréquence respiratoire	Douleur	HGT	Hemocue	...

Verso



Antécédents :

Médicaux :

Chirurgicaux :

Allergies :

Traitements anticoagulants significatifs :

Facteurs de risques cardio-vasculaire :

- ☐ Homme > 50 ans
- ☐ Femme > 60 ans
- ☐ Tabagisme actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans.
- ☐ Antécédents familiaux d'IDM ou mort subite chez le père ou la mère avant 60 ans.
- ☐ AVC avant l'âge de 45 ans.
- ☐ HTA permanente traitée ou non.
- ☐ Diabète de type 2 traitée ou non.
- ☐ Hypercholestérolémie

Notion d'isolement :

Hospitalisation ou soins à l'étranger au cours des 12 derniers mois ? ☐ **Oui** ☐ **Non**

Bracelet d'identification ☐

Soins effectuées : ☐ ECG
☐ Deshabillage ☐ Vêtement détruits ☐ Vestiaire ☐ Dépôt coffre
☐ Pansement ☐ Pot à ECBU donnée ☐ Oxygène ☐ Radio prescrite

Effets personnels : ☐ Prothèse dentaire Haut ☐ Prothèse dentaire Bas
☐ Prothèse auditive Gauche ☐ Prothèse auditive Droite ☐ Lunettes / Etui à lunettes

OBSERVATION MEDICALE

Recto

GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH — Hôpital Paris Saint-Joseph

Etiquette patient

SERVICE DES URGENCES

HEURE D'INSTALLATION DANS LE BOX

Infirmière de soins	Aide-soignant

PRISE DE CONSTANTES

HEURE	PLS	T.A.	T°	SATU.	F. Resp	Dextro	EVA

Bandelette Urinaire

Leucocytes		Sang	
Nitrites		Acétone	
Protéines		Glucose	

PRISE EN CHARGE MEDICALE :

Heure :	Nom – Prénom : Fonction :	Signature :

ANTECEDENTS :

OBSERVATION :

TRAITEMENT ACTUEL :

Verso

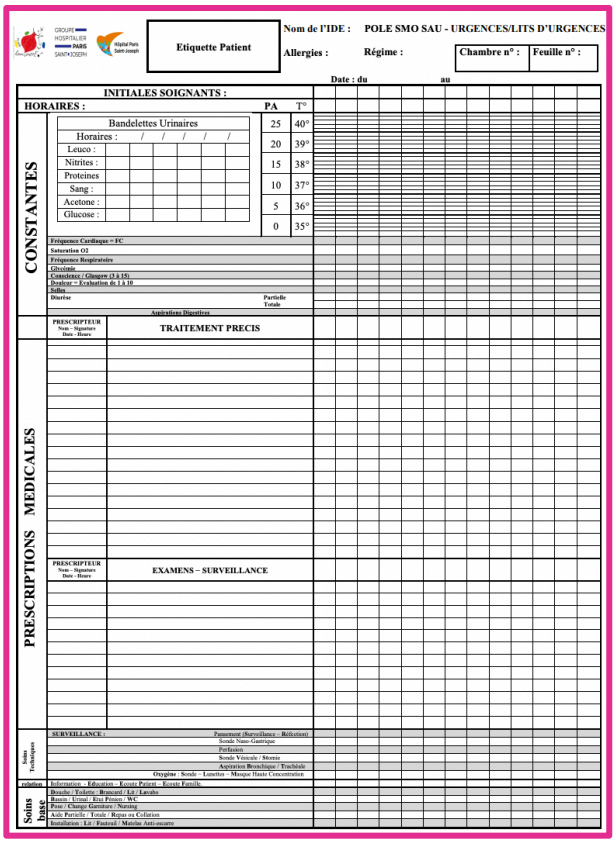
CONCLUSION :

REMPLIR IMPERATIVEMENT LA FEUILLE DE CODAGE (diagnostic, actes, etc …)

	Prescrit	Fait	N° Lot
VAT			
G. Glob. Anti T			

DIAGRAMME DE SOINS

Recto



GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH — Hôpital Paris Saint-Joseph

Etiquette Patient

Nom de l'IDE : POLE SMO SAU - URGENCES/LITS D'URGENCES

Allergies : Régime : Chambre n° : Feuille n° :

Date : du au

INITIALES SOIGNANTS :

HORAIRES :

CONSTANTES

Bandelettes Urinaires						
Horaires :	/	/	/	/	/	/
Leuco :						
Nitrites :						
Proteines						
Sang :						
Acetone :						
Glucose :						

PA	T°
25	40°
20	39°
15	38°
10	37°
5	36°
0	35°

Fréquence Cardiaque = FC
Saturation O2
Fréquence Respiratoire
Glycémie
Conscience / Glasgow (3 à 15)
Douleur = Evaluation de 1 à 10
Selles
Diurèse — Partielle / Totale
Aspirations Digestives

PRESCRIPTIONS MEDICALES

PRESCRIPTEUR Nom – Signature Date - Heure

TRAITEMENT PRECIS

PRESCRIPTEUR Nom – Signature Date - Heure

EXAMENS – SURVEILLANCE

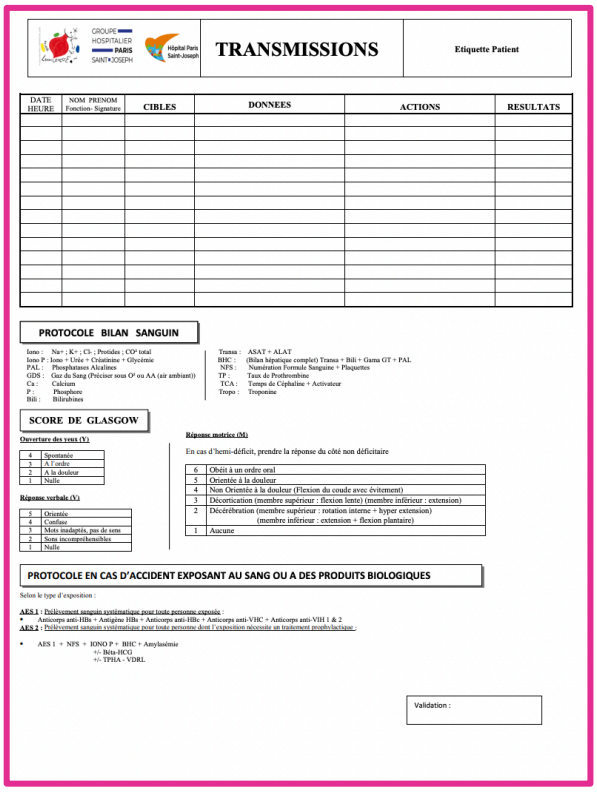
Soins Techniques

SURVEILLANCE : Pansement (Surveillance – Réfection)
Sonde Naso-Gastrique
Perfusion
Sonde Vésicale / Stomie
Aspiration Bronchique / Trachéale
Oxygène : Sonde – Lunettes – Masque Haute Concentration

Prévention Information – Education – Ecoute Patient – Ecoute Famille

Soins de Base Douche / Toilette / Brossage / Lit / Lavabo
Bassin / Urinal / Etui Pénien / WC
Peau / Change Garniture / Nursing
Aide Partielle / Totale / Repas ou Collation
Installation / Lit / Fauteuil / Matelas Anti-escarre

Verso



GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH — Hôpital Paris Saint-Joseph

TRANSMISSIONS

Etiquette Patient

DATE HEURE	NOM PRENOM Fonction- Signature	CIBLES	DONNEES	ACTIONS	RESULTATS

PROTOCOLE BILAN SANGUIN

Iono : Na+ ; K+ ; Cl- ; Protides ; CO² total
Iono P : Iono + Urée + Créatinine + Glycémie
PAL : Phosphatases Alcalines
GDS : Gaz du Sang (Préciser sous O² ou AA (air ambiant))
Ca : Calcium
P : Phosphore
Bili : Bilirubines
Transa : ASAT + ALAT
BHC : (Bilan hépatique complet) Transa + Bili + Gama GT + PAL
NFS : Numération Formule Sanguine + Plaquettes
TP : Taux de Prothrombine
TCA : Temps de Céphaline + Activateur
Tropo : Troponine

SCORE DE GLASGOW

Ouverture des yeux (Y)

4	Spontanée
3	A l'ordre
2	A la douleur
1	Nulle

Réponse verbale (V)

5	Orientée
4	Confuse
3	Mots inadaptés, pas de sens
2	Sons incompréhensibles
1	Nulle

Réponse motrice (M)

En cas d'hemi-déficit, prendre la réponse du côté non déficitaire

6	Obéit à un ordre oral
5	Orientée à la douleur
4	Non Orientée à la douleur (Flexion du coude avec évitement)
3	Décortication (membre supérieur : flexion lente) (membre inférieur : extension)
2	Décérébration (membre supérieur : rotation interne + hyper extension) (membre inférieur : extension + flexion plantaire)
1	Aucune

PROTOCOLE EN CAS D'ACCIDENT EXPOSANT AU SANG OU A DES PRODUITS BIOLOGIQUES

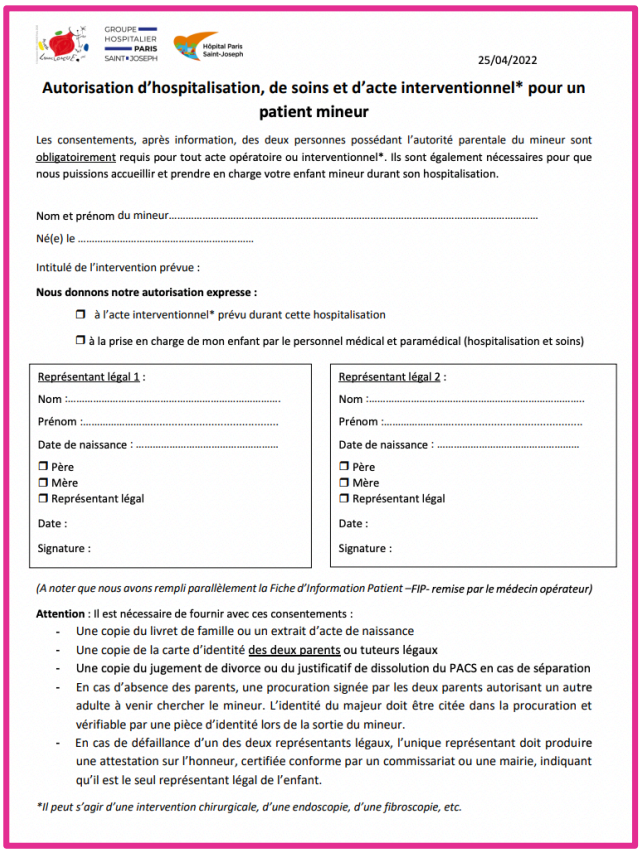
Selon le type d'exposition :

AES 1 : Prélèvement sanguin systématique pour toute personne exposée :
- Anticorps anti-HBs + Antigène HBs + Anticorps anti-HBc + Anticorps anti-VHC + Anticorps anti-VIH 1 & 2

AES 2 : Prélèvement sanguin systématique pour toute personne dont l'exposition nécessite un traitement prophylactique :
- AES 1 + NFS + IONO P + BHC + Amylasémie
  +/- Béta-HCG
  +/- TPHA - VDRL

Validation :

AUTORISATION



GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH — Hôpital Paris Saint-Joseph

25/04/2022

Autorisation d'hospitalisation, de soins et d'acte interventionnel* pour un patient mineur

Les consentements, après information, des deux personnes possédant l'autorité parentale du mineur sont obligatoirement requis pour tout acte opératoire ou interventionnel*. Ils sont également nécessaires pour que nous puissions accueillir et prendre en charge votre enfant mineur durant son hospitalisation.

Nom et prénom du mineur.....

Né(e) le .....

Intitulé de l'intervention prévue :

Nous donnons notre autorisation expresse :

❒ à l'acte interventionnel* prévu durant cette hospitalisation

❒ à la prise en charge de mon enfant par le personnel médical et paramédical (hospitalisation et soins)

Représentant légal 1 :	Représentant légal 2 :
Nom :.....	Nom :.....
Prénom :.....	Prénom :.....
Date de naissance :	Date de naissance : .....
❒ Père ❒ Mère ❒ Représentant légal	❒ Père ❒ Mère ❒ Représentant légal
Date :	Date :
Signature :	Signature :

(A noter que nous avons rempli parallèlement la Fiche d'Information Patient –FIP- remise par le médecin opérateur)

Attention : Il est nécessaire de fournir avec ces consentements :

- Une copie du livret de famille ou un extrait d'acte de naissance
- Une copie de la carte d'identité des deux parents ou tuteurs légaux
- Une copie du jugement de divorce ou du justificatif de dissolution du PACS en cas de séparation
- En cas d'absence des parents, une procuration signée par les deux parents autorisant un autre adulte à venir chercher le mineur. L'identité du majeur doit être citée dans la procuration et vérifiable par une pièce d'identité lors de la sortie du mineur.
- En cas de défaillance d'un des deux représentants légaux, l'unique représentant doit produire une attestation sur l'honneur, certifiée conforme par un commissariat ou une mairie, indiquant qu'il est le seul représentant légal de l'enfant.

**Il peut s'agir d'une intervention chirurgicale, d'une endoscopie, d'une fibroscopie, etc.*

IOIO

lj

Mes livrets d'accueil

Tome 1 - La fondation et l'hôpital

Tome 2 – Le service des urgences

Tome 3 – Mon intégration

Tome 4 – Mon plan de formation et le développement de mes compétences

Tome 5 – Mes outils du quotidien

Tome 6 – Les logiciels Ressources Humaines

Tome 7 – Les logiciels métiers

Tome 8 – Les procédures et protocoles du service et de l'institution

Tome 9 – Situation sanitaire exceptionnelle